

Độ Sinh Đường

# **YẾU LỰC CHÂM CỨU HỆ ĐẠO DẪN**



Ths. Bs Ngô Tiên Hường

# Chương 1. Sinh lý cơ trong chuỗi vận động

1. Trong hệ Đạo Dẫn, cơ không hoạt động đơn lẻ theo từng bó cơ riêng biệt, mà luôn tham gia vào một chuỗi vận động liên tục.

Mỗi động tác của cơ thể đều là kết quả của:

- sự phối hợp giữa co và giãn,
- giữa tăng và giảm trương lực,
- giữa phát lực và hãm lực,
- giữa đóng và mở của toàn bộ hệ cơ cân.

Vì vậy, sinh lý cơ không thể chỉ quan sát ở một điểm cơ cơ cục bộ, mà phải được nhìn trong toàn bộ quá trình hình thành, dẫn truyền và kết thúc vận động.

2. Một chuỗi vận động sinh lý hoàn chỉnh thường trải qua bốn trạng thái cơ bản.

3. **Cơ co** — tăng trương lực để gồng kéo, hướng động tác về hướng tâm. Đây là giai đoạn phát động lực chủ động của chuỗi vận động.

4. Khi cơ co:

- sợi cơ rút ngắn,
- trương lực tăng lên,
- lực kéo được hình thành,
- từ đó dẫn động bộ phận di chuyển về phía trung tâm lực.

Về mặt cơ học, đây là trạng thái: quy tụ lực, nén lực, tạo trục vận động, và hướng động tác về hướng tâm.

5. Trong Đạo Dẫn, trạng thái này không đơn thuần là “dùng sức”, mà là quá trình: gom lực, khóa trục, dẫn lực theo chuỗi cơ cân.

- Ví dụ: nắm tay, khép vai, thu bụng, kéo chân về... đều thuộc cơ chế co — siết — hướng tâm.

6. Nếu trạng thái này quá mạnh hoặc mất điều hòa:

- cơ sẽ co cứng,
- chuỗi vận động trở nên ngắt đoạn,
- lực bị tụ tại một điểm thay vì truyền liên tục, từ đó sinh đau và hạn chế vận động.

Trong châm cứu hệ Đạo Dẫn và châm cứu Kinh Cân, nhiều chứng đau do “tụ lực sai vị trí” tạo nên các điểm tăng trương lực và gồng siết gọi là điểm Cân Kết, tức lực cơ không được dẫn đi mà bị giữ lại trong cơ.

7. **Giãn cơ** — duy trì lực căng để giảm giữ và hãm biên độ vận động

8. Sau khi lực phát sinh, cơ thể cần một hệ thống kiểm soát để:

- giữ ổn định khớp,
- hãm quán tính,

- và giới hạn biên độ vận động trong phạm vi sinh lý.

Khi đó, cơ duy trì ở trạng thái kéo dài nhưng vẫn duy trì lực căng liên tục. Đây là trạng thái **giãn — căng — giãn giữ**.

9. Về bản chất, đây là cơ chế hãm lực sinh lý. Nếu cơ giúp tạo chuyển động, thì căng giãn giúp:

- kiểm soát chuyển động,
- bảo vệ cấu trúc,
- tránh tổ chức bị bất lịch hoặc vượt quá tầm vận động sinh lý.

10. Ví dụ:

- gân kheo căng để hãm động tác đá chân,
- cơ vai căng để giữ khớp không trật khi vung tay,
- cơ lưng căng để ổn định cột sống khi cúi người.

Trong Đạo Dẫn, đây là trạng thái đặc biệt quan trọng, bởi thân thể không thể vận động tinh tế nếu thiếu cơ chế giãn giữ.

10. Khi hệ thống này suy yếu:

- khớp mất vững,
- vận động rời rạc,
- động tác thiếu kiểm soát,
- dễ chấn thương và sai lệch trục.

Ngược lại, nếu duy trì căng giãn kéo dài:

- sẽ sinh cơ rút cân cơ,
- đau kiểu căng kéo,
- giảm tính đàn hồi mô mềm.

11. Giãn cơ kết hợp tăng trương lực — giữ cấu trúc khi động tác mở cực đại rồi hồi nén

Trong nhiều động tác lớn, cơ thể không dừng lại ở trạng thái mở đơn thuần, mà sau khi mở đến giới hạn sinh lý sẽ xuất hiện một lực giữ nội tại nhằm:

- cố định cấu trúc,
- bảo vệ khớp,
- chuẩn bị cho pha hồi nén hoặc đổi hướng vận động.

12. Đây là trạng thái: giãn nhưng vẫn giữ siết nền bên trong.

Ví dụ:

- kéo cung hết cỡ trước khi buông,
- vươn người tối đa rồi thu về,
- xoay cột sống tới biên độ lớn rồi hồi lực,
- mở ngực cực đại trước khi phát lực cánh tay.

13. Trong trạng thái này: chiều dài cơ tăng, nhưng hệ thần kinh vẫn duy trì một mức trương lực nền để giữ cấu trúc không mất kiểm soát.

Đây là cơ chế: “mở mà không tán”.

14. Nếu mất khả năng giữ này: khớp dễ bật lệch, lực bị thất thoát, động tác mất vững, cơ thể mất tính đàn hồi hồi phục.

15. Trong hệ Đạo Dẫn, nhiều kỹ thuật giữ tấn, treo lực, kéo dẫn hay tích lực đều dựa trên nguyên lý này.

16. Châm cứu khi đó không chỉ tác động lên cơ co cứng, mà còn nhằm: phục hồi khả năng giữ trục trong pha mở, tái lập tính đàn hồi động học của chuỗi cơ cân.

17. **Giãn cơ hoàn toàn** — giải phóng trương lực để hồi phục. Sau vận động co siết và căng giữ, hệ cơ cần chuyển sang trạng thái giải phóng trương lực để hồi phục sinh lý.

Đây là trạng thái: **giãn — lỏng — nghỉ**.

18. Khi đó: trương lực cơ giảm xuống, tuần hoàn được tái lập, chuyển hóa được phục hồi, thần kinh giảm kích hoạt, khí huyết trở về trạng thái điều hòa.

19. Nếu cơ không thể chuyển sang pha thư giãn:

- lực tồn dư sẽ tích tụ,
- phản xạ co bảo vệ tiếp tục duy trì,
- cơ thể rơi vào trạng thái “pha vận động chưa kết thúc”.

20. Đây là nguyên nhân thường gặp của:

- đau mỏi kéo dài,
- mệt mỏi sau vận động,
- mất ngủ (thay đổi tư thế khiến cơ co rút - chùng giãn đột ngột gây giật mình tỉnh giấc),
- co cứng mạn tính,
- suy giảm hồi phục.

21. Trong hệ Đạo Dẫn, thư giãn không phải là mất lực hoàn toàn, mà là khả năng: buông trương lực đúng thời điểm để cơ thể quay trở về trạng thái cân bằng sinh lý.

22. Một chuỗi vận động sinh lý hoàn chỉnh luôn bao gồm: co để phát lực, căng để hãm lực, giữ để ổn định cấu trúc, và buông để hồi phục.

23. Bệnh lý xuất hiện khi một giai đoạn nào đó bị đình trệ hoặc mất điều hòa:

- co mà không buông,
- giãn mà không giữ,
- căng mà không hồi phục,
- hoặc mở mà mất vững.

24. Vì vậy, châm cứu hệ Đạo Dẫn không chỉ điều trị vị trí đau, mà điều chỉnh toàn bộ chuỗi vận động của hệ cơ cân — thần kinh — khớp — tư thế, nhằm phục hồi lại nhịp vận động sinh lý tự nhiên của cơ thể.

## Chương 2. Các yếu tố tham gia trong một tư thế vận động

1. Trong hệ Đạo Dẫn, một động tác không phải là sự hoạt động riêng lẻ của một nhóm cơ hay một khớp đơn độc, mà là kết quả của toàn bộ hệ thống:

- trục thể,
- định hướng vận động,
- phân bố lực,
- ổn định trọng tâm,
- và dẫn truyền lực học toàn thân.

2. Vì vậy, khi quan sát một tư thế hay một động tác, cần nhìn nhận nó như một “cấu trúc vận động hoàn chỉnh”, trong đó mỗi bộ phận đều đảm nhiệm một vai trò riêng biệt nhưng liên hệ chặt chẽ với nhau.

3. Tổng quan về Đạo và Dẫn

### Đạo — Trục thể vận động

“Đạo” là phần tạo nên thể vận động của cơ thể. Bản chất của Đạo là:

- định trục,
- định hướng không gian,
- và tổ chức kết cấu vận động.

4. Mọi động tác đều phải được xây dựng trên một trục thể nhất định. Các biến đổi cơ bản của trục gồm:

- cúi — ngửa,
- nghiêng,
- xoay,
- mở — khép,
- nâng — hạ.

5. Trục thể quyết định:

- hướng truyền lực,
- phân bố trọng lượng,
- độ ổn định của vận động,
- và khả năng duy trì cân bằng.

6. Nếu trục sai:

- lực sẽ bị thất thoát,
- cơ phải bù trừ quá mức,
- vận động trở nên nặng nề và dễ gây tổn thương.

7. Trong châm cứu hệ Đạo Dẫn, nhiều chứng đau mạn tính thực chất bắt nguồn từ sai lệch trục vận động kéo dài.

## **Dẫn — Hướng vận động**

8. Nếu “Đạo” là phần dựng trục, thì “Dẫn” là phần dẫn động tác đi theo một hướng xác định.

Dẫn bao gồm:

- hướng của chi thể,
- hướng đầu mặt,
- hướng ánh nhìn,
- hướng xoay thân,
- và hướng phát lực.

9. Ví dụ:

- với tay lấy vật phía trước,
- xoay người lấy đồ phía sau,
- cúi người nhặt vật dưới đất, đều là các hình thái dẫn động tác khác nhau.

10. Trong Đạo Dẫn, hướng vận động quyết định:

- chuỗi cơ nào được hoạt hóa,
- lực truyền theo đường nào,
- vùng nào chịu tải chính,
- và vùng nào tham gia ổn định.

Cùng một động tác nhưng khác hướng dẫn lực sẽ tạo nên mô hình hoạt động cơ hoàn toàn khác nhau.

11. Phân phối nhiệm vụ trong một chuỗi vận động

Một động tác sinh lý hoàn chỉnh luôn có sự phân công chức năng giữa nhiều nhóm cơ và cấu trúc giải phẫu.

## **Giá đỡ**

12. Giá đỡ là cấu trúc nền tảng chịu tải và nâng đỡ cho bộ phận phía trên vận động.

Ví dụ:

- cột sống cổ là giá đỡ của hộp sọ,
- lồng ngực là giá đỡ của vai,
- khung chậu là giá đỡ của thân trên,
- chi dưới là giá đỡ của toàn bộ cơ thể.

13. Giá đỡ không trực tiếp tạo động tác, nhưng quyết định:

- độ ổn định nền,
- khả năng truyền lực,
- và hiệu quả vận động.

Nếu giá đỡ mất vững:

- các nhóm cơ phía trên sẽ phải tăng co bù trừ,
- dễ sinh đau và rối loạn vận động.

14. Trong điều trị, nhiều trường hợp đau vùng vận động không xuất phát từ nơi đau, mà do hệ giá đỡ bên dưới mất chức năng ổn định, buộc vùng bên trên phải co siết để bù trừ.

### **Chủ vận**

15. Chủ vận là nhóm cơ chính tạo nên động tác tại chỗ. Đây là nguồn lực phát động chủ yếu của vận động.

Ví dụ:

- khi gập khuỷu tay, cơ nhị đầu cánh tay là chủ vận,
- khi đứng lên, nhóm cơ tứ đầu đùi là chủ vận,
- khi vởi tay ra trước, nhóm cơ nâng và đưa vai ra trước giữ vai trò chủ vận.

16. Trong Đạo Dẫn, chủ vận không chỉ tạo lực, mà còn quyết định:

- hướng động tác,
- tốc độ vận động,
- và biên độ phát lực.

### **Đối vận**

17. Đối vận là nhóm cơ thực hiện động tác ngược lại với chủ vận.

Vai trò của đối vận gồm:

- hãm lực,
- kiểm soát biên độ,
- làm mềm chuyển động,
- và bảo vệ khớp.

18. Nếu chủ vận tạo ra chuyển động, thì đối vận giúp chuyển động không trở nên mất kiểm soát.

Trong nhiều bệnh lý:

- đối vận co cứng kéo dài sẽ cản trở vận động,
- hoặc đối vận suy yếu khiến động tác thiếu ổn định.

### **Đồng vận**

19. Đồng vận là các nhóm cơ tham gia hỗ trợ và phối hợp cùng động tác chính. Chúng không trực tiếp tạo vận động tại chỗ, nhưng giúp:

- truyền lực,
- ổn định chuỗi vận động,
- đồng bộ hóa thân thể.

20. Ví dụ: khi gĩa tay ra trước: vai ngực, vai lưng, cơ cổ, cơ quanh xương bả vai, đều tham gia đồng vận.

21. Trong Đạo Dẫn, vận động càng tinh tế thì yêu cầu đồng vận càng cao.

22. Một động tác mạnh nhưng thiếu đồng vận sẽ:

- phát lực rời rạc,
- tiêu hao lớn,
- và dễ gây tổn thương cho gân cơ hoặc khớp liên kế chuyển động đồng vận. .

### **Đối trọng**

23. Đối trọng là bộ phận giúp duy trì trọng tâm và cân bằng cơ thể trong quá trình vận động.

Ví dụ:

- khi đưa tay ra trước, thân mình và chân phải điều chỉnh trọng tâm ra sau,
- khi đá chân, tay và thân sẽ tự động đổi vị trí để giữ cân bằng.

24. Đối trọng giúp:

- tránh ngã,
- duy trì trực,
- và ổn định hệ tiền đình — tư thế.

25. Trong nhiều bệnh lý thần kinh vận động, mất đối trọng là nguyên nhân khiến động tác trở nên vụng về và tiêu hao năng lượng quá mức.

### **Giằng giữ**

26. Giằng giữ là nhóm cơ chịu trách nhiệm ổn định vận động và giới hạn biên độ trong phạm vi sinh lý.

Đây là hệ thống:

- khóa trực,
- giữ khớp không vận động quá tầm,
- hãm quán tính,
- chống lệch trực.

27. Ví dụ: khi vớ tay ra xa: cơ bụng, cơ eo lưng, cơ giữ cột sống, sẽ hoạt hóa để thân người không bị đổ về phía trước.

28. Nếu hệ giằng giữ suy yếu: vận động mất ổn định, lực bị thất thoát, khớp dễ tổn thương.

29. Nếu giằng giữ quá mức: cơ thể trở nên cứng, động tác mất tính mềm mại và liên tục.

### **Tiếp lực**

30. Tiếp lực là các nhóm cơ hoặc chuỗi vận động tham gia gia tăng và dẫn truyền lực cho động tác chính. Đây là cơ chế: “lực sinh ở dưới, truyền ra ngoài”.

31. Ví dụ: khi vớ tay lấy vật, thì lực không chỉ đến từ cánh tay, mà còn từ: chân, hông, thân mình, vai, rồi mới truyền tới bàn tay.

32. Tiếp lực giúp:

- giảm tải cho vùng vận động chính,
- tăng hiệu quả phát lực,
- và tạo sự liên tục trong chuỗi vận động.

33. Trong Đạo Dẫn, vận động hiệu quả không dựa trên “dùng sức cục bộ”, mà dựa trên khả năng huy động toàn bộ chuỗi tiếp lực.

34. Ví dụ với động tác giơ tay với lấy vật phía trước. Khi cánh tay đưa ra trước để lấy một vật ở xa:

- Chủ vận: nhóm cơ nâng và đưa cánh tay ra trước.
- Đối vận: nhóm cơ phía gan tay và các cơ kéo tay trở về.
- Đồng vận: vai ngực, vai lưng, cơ quanh xương bả vai, cơ cổ.
- Giữ giữ: cơ bụng, eo lưng và cơ ổn định cột sống.
- Đối trọng: thân dưới và cánh tay bên đối diện điều chỉnh trọng tâm ra sau để giữ cân bằng.
- Tiếp lực: chuỗi lực từ bàn chân → cẳng chân → đùi → khung chậu → thân mình → vai → cánh tay.
- Giá đỡ: chi dưới và khung chậu tạo nền chịu tải cho toàn bộ động tác.

35. Một động tác sinh lý không phải là hoạt động riêng lẻ của một nhóm cơ, mà là kết quả phối hợp của: trục thể, định hướng vận động, ổn định nền, phân bố lực, hãm lực, và dẫn truyền lực toàn thân.

36. Châm cứu hệ Đạo Dẫn vì vậy không chỉ điều trị “nơi đau”, mà phải nhận diện: bộ phận phát lực, vùng mất ổn định, chuỗi bù trừ, và hướng vận động sai lệch hoặc hạn chế vận động. Mục tiêu cuối cùng là phục hồi lại sự hài hòa của toàn bộ chuỗi vận động sinh lý.

## Chương 3. Nguyên lý châm cứu hệ Đạo Dẫn

1. Châm cứu hệ Đạo Dẫn không lấy “vị trí đau” làm trung tâm, mà lấy “chuỗi vận động bệnh lý” làm đối tượng điều chỉnh.

2. Một động tác bất thường của cơ thể thường không phát sinh từ một cơ đơn độc, mà do:

- sai lệch trục thể,
- mất ổn định giá đỡ,
- rối loạn dẫn truyền lực,
- mất phối hợp đồng vận,
- hoặc mất cân bằng giữa phát lực và hãm lực.

3. Vì vậy, mục tiêu điều trị không phải chỉ giảm đau, mà là:

- tái lập cấu trúc vận động sinh lý,
- phục hồi chuỗi dẫn lực,
- và đưa cơ thể trở lại trạng thái vận động liên tục, ổn định, tiết kiệm năng lượng.

### Nguyên tắc 1: Ưu tiên ổn định giá đỡ

4. Trong mọi chuỗi vận động, giá đỡ là nền tảng của phát lực và ổn định. Nếu giá đỡ mất vững:

- cơ phía trên sẽ phải co siết bù trừ,
- dẫn tới trương lực tăng trong thời gian dài,
- lực dẫn truyền ngắt đoạn,
- từ đó vận động trở nên nặng nề và thiếu ổn định.

5. Vì vậy, nguyên tắc đầu tiên của châm cứu hệ Đạo Dẫn là: ưu tiên phục hồi sự ổn định của giá đỡ trước khi xử lý nơi phát lực. Ví dụ:

- đau vai nhưng nền mất vững nằm ở lồng ngực hoặc cột sống ngực,
- đau cổ nhưng nguyên nhân ở vùng vai đai hoặc trục thân,
- đau mắt thất lưng nhưng giá đỡ suy yếu là khung chậu và chi dưới.

6. Khi giá đỡ được tái lập:

- trương lực bù trừ giảm xuống,
- động tác tự nhiên trở nên nhẹ nhàng linh hoạt hơn,
- và vùng đau thường tự giải phóng.

### Nguyên tắc 2: Động tác mang tải yếu — điều chỉnh hệ tiếp lực

7. Các động tác: kéo, đẩy, nâng, chống đỡ, đều thuộc nhóm vận động mang tải. Khi bệnh nhân cảm thấy:

- yếu lực,
- hụt lực,
- phát lực không tới,
- hoặc càng dùng sức càng mỏi, nguyên nhân thường không nằm hoàn toàn ở chủ vận, mà ở sự suy giảm của chuỗi tiếp lực.

8. Tiếp lực là hệ thống dẫn truyền và cộng hưởng lực từ: chân, khung chậu, thân mình, vai, đến ngón chi.

9. Nếu tiếp lực mất liên tục:

- lực sẽ bị đứt đoạn,
- chủ vận phải làm việc quá mức,
- sinh đau và nhanh mỏi.

10. Nguyên tắc điều trị khi đó là:

- khơi thông chuỗi dẫn lực,
- tái lập liên kết giữa các đoạn vận động,
- và phục hồi khả năng truyền lực toàn thân.

### **Nguyên tắc 3. Mất liên lạc vận động — điều chỉnh hệ đồng vận**

11. Một vận động khỏe không chỉ cần lực mạnh, mà còn cần sự phối hợp nhịp nhàng. Khi bệnh nhân xuất hiện:

- động tác rời rạc,
- thiếu liên tục,
- chuyển động không mượt,
- hoặc “không nghe theo chuyển động của thể hoặc tư thế dẫn hướng”, thường là biểu hiện của rối loạn đồng vận.

12. Đồng vận là cơ chế phối hợp giữa: thân trục, vai, cổ, hông, và các chuỗi cơ hỗ trợ.

Nếu đồng vận suy giảm: lực phát ra thiếu thống nhất, động tác bị chia cắt từng đoạn, tiêu hao năng lượng tăng cao.

13. Trong châm cứu hệ Đạo Dẫn, điều trị không nhằm tăng sức co cục bộ, mà nhằm:

- phục hồi nhịp phối hợp giữa các chuỗi vận động,
- giúp cơ thể chuyển động như một chỉnh thể liên tục.

### **Nguyên tắc 4: Run, bù trừ lớn, chệnh choáng — điều chỉnh hệ đối trọng**

14. Khi vận động, cơ thể luôn phải duy trì cân bằng trọng tâm. Nếu hệ đối trọng mất điều hòa:

- động tác sẽ run,
- thân thể phải bù trừ (bao gồm tư thế và động tác) quá mức,
- xuất hiện cảm giác chệnh choáng,
- hoặc dễ ngã đổ.

15. Ví dụ:

- đưa tay nhưng thân nghiêng quá nhiều,
- bước chân nhưng vai lắc mạnh,
- xoay người nhưng trọng tâm lệch khỏi trục.

Đây không đơn thuần là vấn đề sức cơ, mà là rối loạn điều hòa trọng tâm vận động.

16. Nguyên tắc điều trị: cân chỉnh trục trọng tâm, phục hồi cơ chế giữ cân bằng, giảm bù trừ ngoài ý muốn, tái lập ổn định động học toàn thân.

### **Nguyên tắc 5: Hạn chế tầm vận động xa — điều chỉnh giằng giữ ; Hạn chế vận động gần — điều chỉnh đồng vận**

17. Trong hệ Đạo Dẫn, hạn chế vận động cần được phân biệt theo khoảng vận động.

**Hạn chế vận động xa;** nếu động tác:

- không vươn xa được,
- khó mở rộng biên độ,
- hoặc căng tức khi tới cuối tầm, thường liên quan đến hệ giằng giữ.

8. Nguyên nhân là: cơ chế hãm lực quá mạnh, chuỗi cân cơ căng giữ kéo dài, hoặc phản xạ bảo vệ chưa được giải phóng.

9. Khi đó cần: giải phóng hệ giằng giữ, phục hồi tính đàn hồi, mở lại biên độ vận động sinh lý.

10. **Hạn chế vận động gần;** Nếu bệnh nhân:

- khó khởi động động tác,
- động tác ngắn thiếu liên tục,
- hoặc chuyển động gần thân bị vụng, thường liên quan đến rối loạn đồng vận.

11. Đây là tình trạng: lực không được dẫn truyền liên tục, thân thể không phối hợp được chuỗi vận động nền.

Điều trị cần tập trung: tái lập phối hợp vận động, đồng bộ hóa chuỗi cơ hỗ trợ.

### **Nguyên tắc 6: Hạn chế gấp — duỗi tại chỗ: cân đối chủ vận và đối vận**

12. Mọi vận động gấp — duỗi đều tồn tại cân bằng giữa: chủ vận tạo lực, và đối vận hãm lực.

- Nếu chủ vận quá mạnh: vận động trở nên cứng và giật cục.
- Nếu đối vận quá căng: biên độ bị khóa, động tác nặng nề và đau mỏi.

13. Vì vậy, nguyên tắc điều trị không phải: “tăng lực một bên”, mà là: tái lập cân bằng động giữa chủ vận và đối vận.

Khi cân bằng được phục hồi: động tác sẽ mềm, lực đi liên tục, biên độ tự mở ra.

### **Nguyên tắc 7: Quy chiếu vận động về các thể cơ bản**

14. Dù động tác phức tạp đến đâu, đều có thể quy chiếu về các thể vận động cơ bản của cơ thể gồm: cúi — ngửa, nghiêng, xoay, gấp — duỗi, dạng — khép.

Đây là nguyên tắc phân tích cốt lõi của hệ Đạo Dẫn.

15. Một động tác phức hợp thực chất là: sự chồng lấp của nhiều thể cơ bản diễn ra đồng thời.

Khi quy chiếu được động tác: sẽ xác định được trục vận động chính, vùng giằng giữ, chuỗi tiếp lực, và nơi mất ổn định trong từng pha vận động.

16. Từ đó lựa chọn: huyết vị, hướng châm, tư thế vận động, và chiến lược điều chỉnh phù hợp.

### **Ví dụ phân tích vận động theo hệ Đạo Dẫn**

17. Động tác: đưa tay xuống dưới, ra sau, gập khuỷu, rồi đưa ngón chi hướng lên chạm vùng cổ sau.

Thoạt nhìn đây là một động tác phức tạp, nhưng có thể quy chiếu thành hai thể chính:

- thể xoay: xuất hiện khi cánh tay đưa ra sau thân.
- thể ngửa: xuất hiện khi cột sống ngực và thắt lưng uốn để khuỷu hướng lên trên.

18. Trong chuỗi này:

- vai và cánh tay là chủ vận,
- vùng vai ngực và vai lưng tham gia đồng vận,
- vùng bụng và mạn sườn đối bên tham gia giằng giữ để giữ trục xoay,
- khung chậu và chi dưới đóng vai trò giá đỡ và đối trọng.

19. Nếu bệnh nhân hạn chế động tác: không chỉ xử lý vùng vai, mà cần xác định: nơi mất xoay, vùng giằng giữ quá mức, và chuỗi tiếp lực bị ngắt đoạn.

20. Châm cứu hệ Đạo Dẫn là phương pháp: phân tích vận động, nhận diện chuỗi rối loạn, và tái lập lại cấu trúc động học sinh lý của cơ thể.

21. Điều trị không hướng tới “giảm đau tại chỗ”, mà hướng tới: phục hồi trục vận động, tái lập dẫn lực, cân bằng phát lực và hãm lực, và đưa cơ thể trở về trạng thái vận động tự nhiên, ổn định và liên tục.

## Chương 4. Phương pháp châm trong hệ Đạo Dẫn

1. Trong hệ Đạo Dẫn, châm cứu không chỉ là phương pháp kích thích huyết vị để giảm đau hay điều hòa khí huyết, mà là phương pháp can thiệp trực tiếp vào cấu trúc vận động của cơ thể.
2. Kim châm được sử dụng như một điểm dẫn động, một điểm khóa trục, hoặc một điểm tái phân bố trương lực trong toàn bộ chuỗi cơ cân. Vì vậy, ý nghĩa của châm không nằm riêng ở vị trí đắc khí, mà nằm ở khả năng làm thay đổi cách cơ thể vận động, giữ thể và truyền lực.
3. Một người đau vai có thể không nằm ở vấn đề của vai. Một người yếu chân có thể không nằm ở sức cơ của chân. Điều cốt lõi là chuỗi vận động đã mất cân bằng: nơi phát lực sai, nơi giữ trục suy yếu, nơi giằng giữ quá mức hoặc nơi tiếp lực bị ngắt đoạn. Châm cứu hệ Đạo Dẫn vì vậy không tác động riêng lẻ lên một cơ hay một huyết, mà tác động lên toàn bộ hệ thống vận động của thân thể.
4. Trong quá trình phát triển, hệ Đạo Dẫn hình thành bốn phương pháp châm cơ bản gồm: Động châm, Tỏa châm, Lưu châm và Châm Đạo Dẫn phối hợp.
5. **Động châm** là phương pháp dùng kim để tạo ra chuyển động sinh lý có định hướng. Đây là kỹ thuật quan trọng nhất trong hệ Đạo Dẫn, bởi mục tiêu không phải giữ cơ thể bất động mà là khôi phục khả năng vận động tự nhiên.
6. Trước khi châm, người điều trị phải chuẩn bị tư thế. Tư thế không đơn thuần là cách đứng hay nằm, mà là quá trình dừng lại trục vận động của cơ thể. Cần xác định rõ thân đang ở thế cúi hay ngửa, nghiêng hay xoay, gấp hay duỗi; đồng thời sắp xếp lại giá đỡ, đối trọng và hướng dẫn lực sao cho chuỗi vận động trở nên thuận lợi nhất.
7. Sau khi dựng trục, bước tiếp theo là thiết lập hướng dẫn vận động. Trong hệ Đạo Dẫn, mỗi động tác đều phải có “đường dẫn”. Nếu không có đường dẫn, cơ thể sẽ tự quay về các kiểu bù trừ cũ. Vì vậy, người điều trị cần xác định rõ hướng chuyển động chính, tầng cơ cần tác động, nơi nào cần mở, nơi nào cần giữ, nơi nào cần giằng ổn định.
8. Khi chuỗi vận động đã được sắp xếp, kim mới được đưa vào điểm châm thích hợp. Điểm này không nhất thiết là nơi đau nhất, mà là nơi có khả năng kích hoạt lại vận động sinh lý.
9. Khi châm xuất hiện 2 trường hợp, một là cơ thể bệnh nhân phản ứng tạo chuỗi vận động đúng theo tư thế đã sắp xếp; trường hợp thứ hai chuyển động của bệnh nhân trong khi châm chưa kích hoạt được trạng thái vận động sinh lý, khi này bệnh nhân được yêu cầu tự vận động vùng bệnh theo đúng hướng đã dẫn trước đó.
10. Chính quá trình tự vận động mới là phần quan trọng nhất của Động châm. Khi cơ thể chuyển động đúng, các nhóm cơ co — giãn bắt đầu hoạt động lại theo trình tự sinh lý. Trương lực được tái phân bố, các vùng co giữ bệnh lý dần được giải phóng và biên độ vận động tự mở rộng trở lại.

11. Nếu Động châm là phương pháp “mở chuyển động”, thì Tỏa châm là phương pháp “khóa chuyển động”.

12. **Tỏa châm** là kỹ thuật dùng kim để tạo ra trạng thái ổn định tại một vùng khớp hoặc một bộ phận nhất định. Mục tiêu không phải làm cứng cơ thể, mà là giảm bớt những vận động dư thừa và bù trừ quá mức.

13. Trong nhiều trường hợp, cơ thể đau không phải vì thiếu chuyển động, mà vì có quá nhiều chuyển động sai. Một khớp mất vững sẽ khiến toàn bộ hệ cơ xung quanh phải co siết liên tục để giữ ổn định. Khi đó, nếu tiếp tục mở vận động mà không tạo được điểm tựa ổn định, cơ thể sẽ càng rối loạn hơn.

14. Tỏa châm vì vậy được sử dụng để tạo “điểm neo” cho chuỗi vận động. Có thể khóa gấp, khóa duỗi, khóa vùng hạ bàn như khung chậu và chi dưới, hoặc khóa vùng thượng bộ như cổ vai gáy. Khi một vùng được ổn định lại, lực sẽ không còn phân tán hỗn loạn mà bắt đầu truyền đi rõ ràng hơn. Đồng thời, những vùng khác của cơ thể cũng có thêm không gian vận động.

15. Trong hệ Đạo Dẫn, “khóa” không mang ý nghĩa hạn chế cơ thể, mà là làm vững một trục để phần còn lại được vận động tự do hơn.

16. **Lưu châm** là phương pháp đưa kim xuyên qua các tầng cơ nông và sâu rồi lưu lại trong một khoảng thời gian nhất định để cơ thể tự điều chỉnh trương lực.

17. Khác với nhiều phương pháp châm kích thích mạnh, Lưu châm trong hệ Đạo Dẫn chú trọng vào khả năng tự điều hòa của cơ thể. Khi kim đi qua lớp cơ vỏ và tiến vào tầng cơ lõi, hệ cơ cân bắt đầu xuất hiện những thay đổi vi tế về áp lực và trương lực.

18. Những lớp cơ nông co siết lâu ngày dần buông lỏng. Những lớp cơ sâu vốn bị ức chế bắt đầu hoạt hóa trở lại. Trong quá trình này, cơ thể thường xuất hiện các nhu động rất nhẹ của mô mềm. Kim theo đó cũng dần thay đổi vị trí hoặc bị “đẩy” ra ngoài một cách tự nhiên.

19. Đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang tái lập cân bằng giữa cơ nông và cơ sâu, giữa lớp cơ giữ trục và lớp cơ phát lực. Vì vậy, Lưu châm đặc biệt phù hợp trong các trường hợp cơ cứng mạn tính, mất ổn định tư thế hoặc rối loạn trương lực kéo dài.

20. Từ ba kỹ thuật nền tảng trên, hệ Đạo Dẫn phát triển thành Châm Đạo Dẫn hoàn chỉnh.

21. Châm Đạo Dẫn không phải là một thủ pháp đơn lẻ, mà là phương pháp phối hợp toàn bộ các nguyên lý vận động và kỹ thuật châm để tái cấu trúc lại chuỗi vận động của cơ thể.

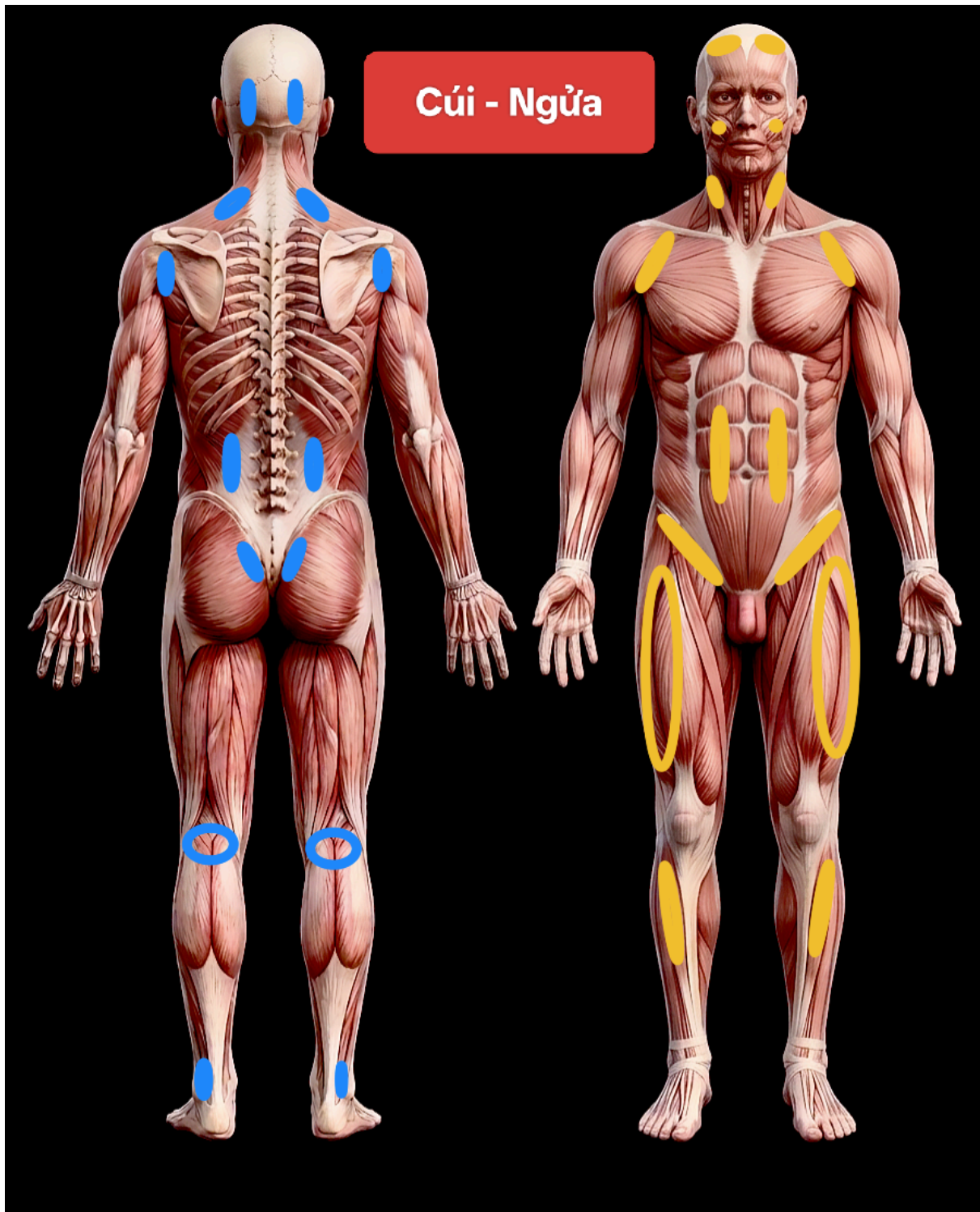
Khi điều trị, người thầy thuốc không chỉ quan sát nơi đau, mà phải phân tích: giá đỡ ở đâu mất vững, chủ vận ở đâu suy yếu, đối vận ở đâu co siết, đồng vận ở đâu mất liên tục, đối trọng ở đâu lệch trục, giữ giữ ở đâu quá mức và tiếp lực ở đâu bị đứt đoạn.

22. Từ đó mới lựa chọn: nơi cần mở, nơi cần khóa, nơi cần dẫn động, nơi cần phục hồi ổn định.

23. Có trường hợp đau vai nhưng phải xử lý vùng khung chậu trước. Có trường hợp đau cổ nhưng cần mở giãn giữ vùng ngực — bụng. Có trường hợp yếu tay nhưng nguyên nhân nằm ở mất tiếp lực từ chân và thân trục.

24. Vì vậy, Châm Đạo Dẫn không điều trị cơ riêng lẻ, mà điều trị toàn bộ cấu trúc vận động của con người.

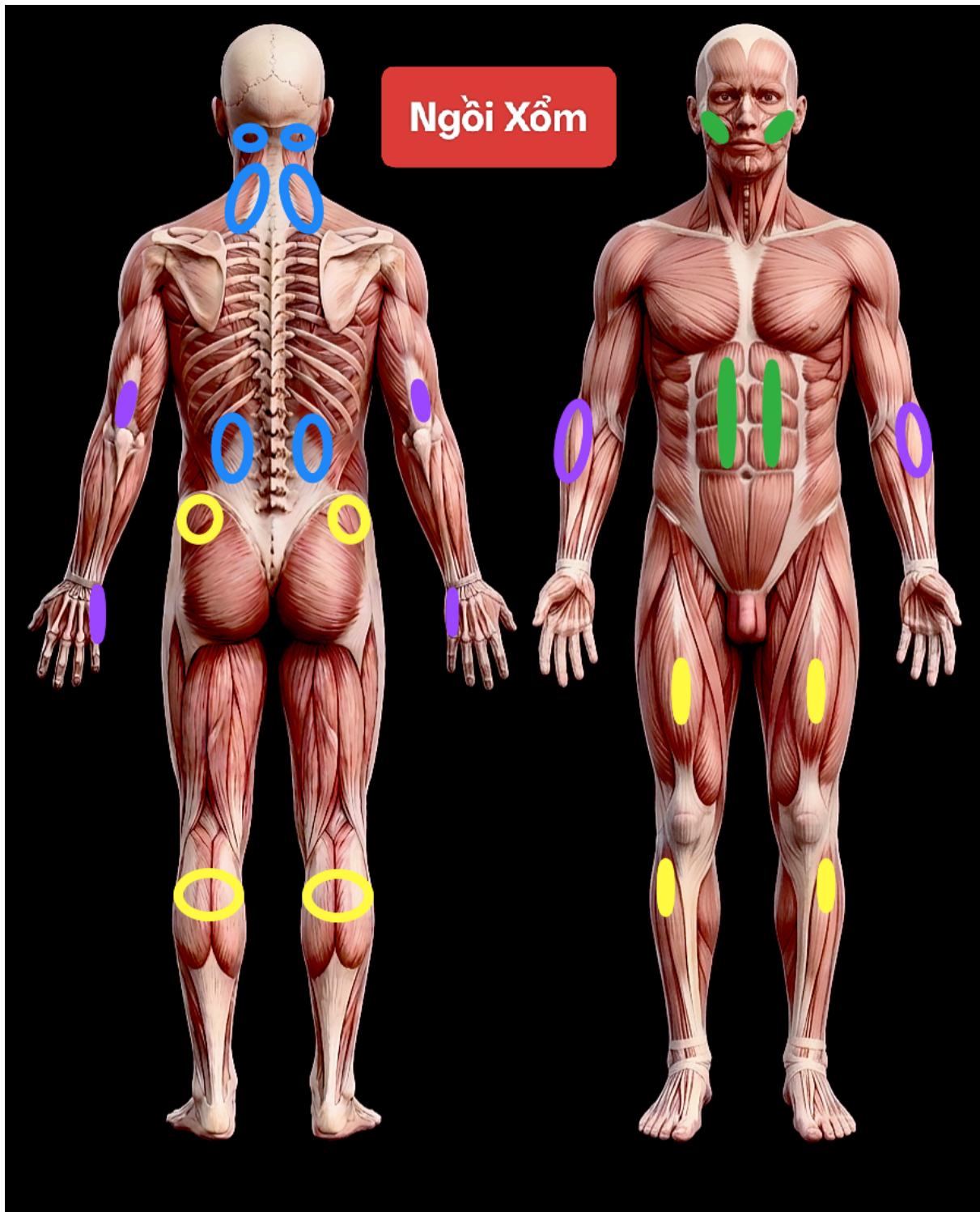
Mục tiêu cuối cùng của phương pháp này không phải chỉ làm hết đau, mà là đưa cơ thể trở về trạng thái: vận động liên tục, phát lực ổn định, chuyển động linh hoạt và tiết kiệm năng lượng



**Đồ Hình Cúi Ngửa**



**Đồ Hình Nghiêng**



**Đồ Hình Tư Thế Ngồi Xồm**



**Tư Thế Giơ Tay**

